

Ostomías y sus complicaciones

1. Introducción y relevancia clínica

Una **ostomía** es una **comunicación quirúrgica del tubo digestivo o urinario con la superficie corporal**, que permite la salida controlada del contenido intestinal o urinario hacia el exterior.

El objetivo puede ser **derivar, descomprimir, drenar o nutrir**.

En cirugía general, las más comunes son:

- **Colostomía:** salida del colon a piel.
- **Ileostomía:** salida del íleon terminal.
- **Urostomía:** derivación urinaria.
- **Gastrostomía / yeyunostomía:** para alimentación o descompresión.

Las ostomías pueden ser **temporales o definitivas**, y su correcta confección, manejo y seguimiento son esenciales para evitar complicaciones metabólicas, mecánicas e infecciosas.

En Chile, son frecuentes en el contexto de:

- **Cáncer colorrectal.**
- **Peritonitis secundaria o trauma intestinal.**
- **Enfermedad diverticular complicada.**
- **Malformaciones congénitas** (en pediatría).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Tipos de ostomías digestivas

Tipo	Localización	Contenido	Características
------	--------------	-----------	-----------------

Colostomía	Colon transverso o sigmoide	Materia fecal sólida	Menor pérdida de agua y electrolitos
Ileostomía	Íleon terminal	Líquido, bilioso, alcalino	Alta pérdida de líquidos, sodio y bicarbonato
Gastrostomía / Yeyunostomía	Estómago / yeyuno	Alimentación o descompresión	Riesgo de fuga o infección local

2.2 Según configuración

Tipo	Descripción	Ejemplo
Terminal	Un solo extremo exteriorizado	Colostomía definitiva tras resección
En asa (loop)	Exteriorización de un asa con 2 bocas (proximal y distal)	Desviación temporal (ej. Hartmann reverso)
Doble cañón	Ambos extremos separados exteriorizados	Anastomosis diferida

2.3 Fisiología del tránsito y adaptación

- **Ileostomía:** alto débito inicial (1–1.5 L/día), que disminuye en semanas por adaptación intestinal.
 - **Colostomía:** flujo más espeso y menos frecuente.
 - El **colon izquierdo** permite mayor reabsorción de agua → mejor tolerancia.
-

2.4 Funciones clínicas

1. **Descompresión intestinal:** obstrucciones, peritonitis, perforaciones.
 2. **Derivación fecal temporal:** para proteger anastomosis bajas o zonas inflamadas.
 3. **Derivación definitiva:** tras resección oncológica o trauma irreparable.
 4. **Nutrición o drenaje gástrico:** gastrostomías o yeyunostomías.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Paciente con ostomía normal

- Estoma rosado, húmedo, protruyente 1–2 cm.
- Salida de gas o materia fecal.
- Piel periestomal intacta.

3.2 Complicaciones más frecuentes

1. **Precoces (<30 días):**
 - Isquemia y necrosis.
 - Retracción o dehiscencia.
 - Fuga periestomal.
 - Infección local.
2. **Tardías (>30 días):**
 - Hernia parastomal.
 - Prolapso del estoma.
 - Estenosis.
 - Dermatitis periestomal.

- Deshidratación (especialmente en ileostomías).

3.3 Diagnóstico diferencial

Síntoma	Diagnóstico posible
Ausencia de débito >24 h	Obstrucción intestinal, edema del estoma
Estoma violáceo o negro	Isquemia o necrosis
Salida de líquido claro abundante	Fístula o filtración
Dolor + fiebre + mal olor	Infección o absceso periestomal
Sangrado leve	Irritación local (habitual)

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

La mayoría de las complicaciones se diagnostican **clínicamente**, pero se complementan con:

- **TAC abdominopélvico con contraste oral y EV:** para descartar abscesos, obstrucción o isquemia.
 - **Endoscopía del estoma:** útil en sospecha de estenosis o prolapso.
 - **Exámenes de laboratorio:** electrolitos, gasometría, creatinina (valorar pérdidas).
 - **Pruebas de función renal:** control en ileostomías de alto débito.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL y WSES 2022)

5.1 Cuidados generales del estoma

- Mantener piel seca y limpia.
 - Usar **dispositivos colectores adecuados** al tipo de ostromía.
 - Cambiar la bolsa cada 3–5 días o antes si hay filtración.
 - Evitar adhesivos irritantes o talcos.
 - Controlar el color, tamaño y protrusión del estoma.
-

5.2 Complicaciones precoces

Complicación	Manejo
Isquemia o necrosis	Si limitada a mucosa → observación; si profunda → reintervención urgente
Retracción del estoma	Cuidado local; si profunda o con fuga → reconstrucción quirúrgica
Fuga periestomal	Ajuste de dispositivos, protección cutánea, revisión técnica
Infección local	Limpieza, antibióticos tópicos o sistémicos
Dehiscencia mucocutánea	Curaciones diarias; cierre secundario o revisión quirúrgica

5.3 Complicaciones tardías

1. Hernia parastomal

- Protrusión de vísceras a través del defecto fascial.
- Manejo: faja de contención; reparación quirúrgica con malla en casos sintomáticos.

2. Prolapso del estoma

- Eversión excesiva (>5 cm).
- Reintroducción manual + compresas frías; cirugía si irreducible o sintomático.

3. Estenosis

- Disminución del calibre con dificultad de evacuación.
- Dilataciones progresivas; cirugía si persistente.

4. Dermatitis periestomal

- Irritación por contacto con efluente o adhesivo.
- Protección cutánea (óxido de zinc, pasta barrera), cambio de dispositivo.

5. Deshidratación (ileostomía)

- Control de pérdidas, suero oral o EV con electrolitos.
- Loperamida o codeína para disminuir el débito.

5.4 Cuidados nutricionales

- **Dieta progresiva y fraccionada.**
- Evitar alimentos productores de gas o diarrea (legumbres, brócoli, fritos).
- Aumentar ingesta de líquidos y sodio en ileostomías.
- Educación nutricional continua.

5.5 Reversión de ostomías

- Indicada en ostomías **temporales** tras resolución del cuadro de base.
- Se realiza idealmente después de **8–12 semanas**, cuando:
 - No hay sepsis ni abscesos.
 - Estado nutricional adecuado.
 - Integridad del segmento distal comprobada (colonoscopia o enema baritado).
- Técnica: cierre del estoma + anastomosis término-terminal.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Incidencia aproximada	Comentario
Dermatitis periestomal	30–40%	La más frecuente
Hernia parastomal	10–25%	Aumenta con obesidad y tos crónica
Prolapso	5–10%	Más en ostomías en asa
Estenosis	2–5%	Causa obstrucción parcial
Isquemia / necrosis	5%	Emergencia quirúrgica
Deshidratación severa	10% en ileostomías	Puede requerir hospitalización

Pronóstico:

- La mayoría de las ostomías son bien toleradas con educación adecuada.
- Las complicaciones se reducen drásticamente con un **equipo de ostomaterapia**.

- Mortalidad directa por ostomía: <1%.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **El estoma normal es rosado, húmedo y protruye ligeramente.**
 2. **Ileostomía = alto débito → riesgo de deshidratación.**
 3. **Colostomía en asa:** generalmente temporal, para desviar tránsito.
 4. **Hernia parastomal** es la complicación tardía más frecuente.
 5. **Educación del paciente y ostomaterapia** son fundamentales para evitar complicaciones.
 6. **Color violáceo o negro del estoma = isquemia → cirugía inmediata.**
 7. **Nunca revertir una ostomía** antes de comprobar la integridad distal (enema o colonoscopia).
-



Errores comunes

- Confundir **retracto** con prolapso (el primero hunde, el segundo protruye).
- No medir el débito en ileostomías.
- Cerrar la ostomía sin confirmar resolución de la patología de base.
- No proteger la piel periestomal ante fugas.
- Creer que toda ostomía es definitiva.
- Ignorar la repercusión emocional del paciente ostomizado.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Ostomía = comunicación quirúrgica controlada del tubo digestivo con la piel.**
2. **Colostomía e ileostomía** son las más frecuentes; pueden ser temporales o definitivas.
3. **Complicaciones precoces:** isquemia, retracción, fuga, infección.
4. **Complicaciones tardías:** hernia parastomal, prolapso, estenosis, dermatitis.
5. **Ileostomías pierden más líquido → riesgo de deshidratación y desequilibrio electrolítico.**
6. **Educación, nutrición y ostomaterapia** son la base del manejo.
7. **Reversión diferida** solo tras resolución del cuadro y evaluación distal.